EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 83060
SERVICIO : UCI HSC
FECHA : 23-04-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JORGE HERNAN FUENTES FUENTES			RUN	: 4.491.772-6
F.Nac	: 14-12-1940	Edad	: 83 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: HUAIRAVOS 1183 PB.11 SEP.			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 59642144		
Fecha Ingreso	: 2024-04-12	Fecha Egreso	: 23-04-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K83.0-COLANGITIS.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. SEPSIS PP BILIAR SOFA 6 PTOS
a. COLANGITIS
b. COLEDOCOLITIASIS
c. PERITONITIS BILIAR
2. POP MEDIATO
a. LAPAROTOMÍA KOCHER
b. COLEDOCOTOMÍA + EXPLORACIÓN DE VÍA BILIAR + COLEDOCORRAFIA + INSERCION DE DRENAJE TUBULAR
3. ICC/HTA
4. FA PAROXÍSTICA
5. BICITOPENIA
a. ANEMIA MODERADA NORMOCÍTICA/NORMOCRÓMICA
b. TROMBOCITOPENIA
6. AKI I/ERC IIIA
7. ALCALOSIS RESPIRATORIA/METABÓLICA
8. DESEQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLÍTICO
a. HIPERNATREMIA
9. HIPOTIROIDISMO
10. CA PROSTATA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R57.2-CHOQUE SEPTICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. R57.2-CHOQUE SEPTICO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

SE TRATA DE PACIENTE MASCULINO DE 83 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES ANTES DESCRITOS, CON CUADRO CLÍNICO DE 3 DÍAS DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN HEMIABDOMEN SUPERIOR ASOCIADO A NAUSEAS Y VÓMITOS, ES LLEVADO A APS SOLICITAN EXÁMENES Y DESTACA HIPERBILIRRUBINEMIA, TRANSAMINASAS HEPÁTICAS ALTERADAS, GGT Y FA ELEVADAS, COMPATIBLES CON SD ICTÉRICO OBSTRUCTIVO, ES DERIVADO AL HSC INGRESA AL S.U A CARGO DE CIRUGIA, QUIEN SOLICITA TAC DE ABDOMEN Y PELVIS DONDE REPORTAN DILATACIÓN DE VIDA BILIAR Y COLEDOCOLITIASIS, SE PLANTEA DIAGNOSTICO DE COLANGITIS, INDICAN VOLEMIZACIÓN, ATB Y SOLICITAN CEPRE. PACIENTE EVOLUCIONA DE FORMA TÓRPIDA CON INESTABILIDAD HEMODINAMICA, REQUERIMIENTOS DE DVA, EN EL CONTROL DE LABORATORIOS, PCR AL ALZA, MAYOR COMPROMISO DEL PERFIL HEPÁTICO, ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN, TROMBOCITOPENIA, SOLICITAN EVALUACIÓN POR UPC, INICIALMENTE NO SE DECIDE INGRESO POR NO CONTAR CON PLAN QUIRÚRGICO PERO POSTERIORMENTE DECIDEN OPERAR Y SE INGRESA. PACIENTE EN MALAS CONDICIONES, CON NRA A 0.29 MCG/KG/MIN, MAL PERFUNDIDO A DISTAL, ANURICO, CON DOSIS

DE NRA AL ALZA HASTA 0.4 MCG/KG/MIN POR LO QUE SE DECIDE MANEJO AVANZADO DE LA VÍA AÉREA CON TOT N° 8, CON PROTOCOLO DE SECUENCIA RÁPIDA CON ETOMIDATO 20MG, KETAMINA 100 MG Y SUCCINILCOLINA 100 MG, SIN INCIDENTES. PACIENTE CON PRONOSTICO OMINOSO, SE LE COMUNICA A FAMILIARES.
EVOLUCIÓN POR SISTEMAS:
HEMODINAMIA: INICIALMENTE INGRESA A HSC NORMOTENSO PA 145/65 MMHG PERO HORAS DESPUES SE COMPROMTE Y SE HIPOTENSA HASTA 60/30 MMHG AMERITANDO DVA Y VOLEMIZACIÓN CON SOLUCIÓN RINGER, A UCI INGRESA PA 77/55 MMHG PAM 65 Y CON NOREPINEFRINA 0.3 µCG/KG/MIN REQUIRIENDO AUMENTAR HASTA 0.7 µCG/KG/MIN , ADEMAS TAQUICARDICO FC 112 LPM , ADEMAS MAL PERFUNDIDO, LACTATO 6.2 , TROMBOCITOPENICO Y PERFIL DE COAGULACION PROLONGADO PERO EN URGENCIA YA SE HABIA TRANSFUNDIDO 3 UDS PLASMA FRESCO CONGELADO Y 6 UD CONCENTRADO PLAQUETARIO. LUEGO DE LAS 1ERAS 24 HORAS EN UCI Y ADEMAS POST OPERADO, MEJORA PERFUSIÓN, EMPIEZA A BARRER LACTATO (6.2-3.4-2.5-1.7-1.4) HASTA 0.8 ACTUAL, DISMINUCIÓN PROGRESIVA DE NAD, EL 13/04/2024 PRESENTA EPISODIO DE FARVR CON FC >260 LPM + INESTABILIDAD HEMODINAMICA QUE AMERITA CVE CON 100 JOULES CARDIOVIRTIENDO A RITMO SINUSAL. LAS 1ERAS 72 HORAS QUEDANDO CON BHA MUY POSITIVO HASTA (+)7270 Y EVIDENCIANDO EDEMA Y YUGULARES INGURGITADAS POR LO QUE SE INICIAN DIURETICOS DE ASA Y DOBUTAMINA HASTA UN MAXIMO 2.5 µCG/KG/MIN, MOSTRANDO RESPUESTA SATUSFACTORIA, EL 1ER DIA QUEDA CON BH NEUTRO Y EN ADELANTE BH NEGATIVOS + DISMINUCION DEL EDEMA, NO PRESENTA NUEVAMENTE ARRITMIAS, MANTENIENDOSE EN RITMO SINUSAL, EL 17/04/2024 SE OMITE DOBUTAMINA. INGRESA CON TROMBOCITOPENIA CON PLAQUETAS 26.000 SE TRANSFUNDE EN URGENCIA PARA SER LLEVADO A PABELLON, LUEGO CAEN A 17.000 PERO SIN MANIFESTACIONES DE SANGRADO POR LO QUE SE MANEJA DE FORMA EXPECTANTE APRECIANDO ASCENSO PROGRESIVO . ACTUALMENTE SIN DVA, HTA CON PAS MAXIMO 160 Y PAD MAXIMO 100, RITMO SINUSAL CON FC 96-86 LPM, BH (+)52 BHA (-) 2830 HB 9.3 PLAQUETAS 97.000.
VENTILATORIO: SE INTUBA EL 12/04/2024 A LAS 12:20 H POR SHOCK SEPTICO Y NAD A MUY ALTAS DOSIS , ADEMÁS IBA A PABELLÓN, SE TITULA FIO2 30% Y SE MANTIENE EN ESE RANGO LAS 1ERAS 24 H ADEMAS DE SEDACIÓN PROFUNDA, PAFI 240-295, DESDE EL 14/04/2024 SE EMPIEZA A DISMINUOIR SEDOANALGESIA Y EL 15/04/2024 QUEDA UNICAMENTE CON DEXMEDETOMIDINA Y SE CAMBIA A P/C PAFI 192/218, SE ADICIONAN NEUROLEPTICOS Y SE PROGRESA WEANING CAMBIANDO A CPAP +PS Y EL 17/04 SE DEJA EN TUBO T PROGRESANDO HASTA EXTUBACIÓN EL 18/04/2024 A LAS 13:55 H SALE A MAV PERO SE CAMBIA A VMNI POR FR AUMENTADA PERO AL SIGUIENTE DIA PASA A NARICERA Y ACTUALMENTE FIO2 21% FR 22-28 RPM, SATURANDO 92-94%, PAFI 296.
INFECCIOSO: NO ESTUVO FEBRIL EN LA URGENCIA NI TAMPOCO DURANTE SU PERMANENCIA EN UCI, SIN EMBARGO INGRESA CON PARAMETROS INFLAMATORIOS ELEVADOS PCR 336 Y PROCALCITONINA 77.2, SE PANCULTIVA Y SE INDICA CEFTRIAXONA/METRONIDAZOL, EN CULTIVO INTRAOPERATORIO SE AISLA ESCHERICHIA COLI SENSIBLE A CEFTRIAXONA, PCR EMPIEZA A DISMINUIR PROGRESIVAMENTE AL IGUAL QUE LA PROCALCITONINA QUEDANDO ACTUALMENTE PCR 48.5
NEFROMETABÓLICO: INGRESA CON CREATININA 2.70 Y ASCIENDE HASTA 3.10 AL IGUAL UREMIA HASTA 193 Y BUN 90 + ACIDOSIS METABÓLICA PH 7.33 HCO3 19, SIN ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS, PERO OLIGO-ANURICO CON DIURESIS <300 ML LAS 1ERAS 48 HORAS, CONFORME A EVOLUCIÓN, VOLEMIZACIÓN , ADMINISTRACIÓN DE ALBÚMINA, INÓTROPOS Y POSTERIORMENTE DIURETICOS SEESTABILIZAN PRUEBAS DE FUNCIONALISMO RENAL, DISMINUCIÓN DE CREATININA-UREMIA-BUN, CORRECCIÓN DE ACIDOSIS METABÓLICA. ACTUALMENTE POLIURICO, CREATININA EN DISMINUCIÓN, HIPERNATREMIA LEVE , ALCALOSIS METABÓLICA RECIBE ALIMENTACIÓN POR VÍA ORAL.

PLAN DE MANEJO:

CONTROL EN 15 DIAS

INDICACIONES AL ALTA

1. BISOPROLOL 2.5 MG: 1 COMPRIMIDO DIARIO 9AM
2. LOSARTAN 50 MG: 1 COMPRIMIDO CADA 12 HS 9AM-21 HS
3. ALOPURINOL 100 MG: 1 COMP DIARIO 17 HS
4. METOLAZONA 2.5 MG: 1 COMPRIMIDO DIARIO 11 AM
5. LEVOTIROXINA 100 MCG: ½ COMPRIMIDO DIARIO EN AYUNAS
6. QUETIAPINA 25 MG: 1 COMPRIMIDO DIARIO ANTES DE ACOSTARSE
7. ESPIRONOLACTONA 25 MG: 1 COMPRIMIDO DIARIO 15 HS
8. REGIMEN LIVIANO
9. CURACIONES EN CONSULTORIO DE APS CADA 48 HS
10. CONTROL EN POLI CLINICO DE CIRUGIA EN 15 DIAS

11. DEFINIR INICIO DE ANTICOAGULACIÓN EN EL CONTROL POLI ALTA DE ACUERDO A RESULTADOS DE HEMOGRAMA (PLAQUETAS)

EXÁMENES Y RESULTADOS

LAB 23/04/2024 ALB 3.1 CREA 0.7 FA 161 BT 1.5 LDH 309 LACT 0.9 NA+ 139 K+ 3.8 CL- 101 TSH 10.042 T4 L: 1.250
LAB 20/04/2024 LEUC: 15,100 HTO : 27,7 HB: 9,3 PLAQ: 76.000 VHS 6 TP 65 INR 1.33 GLIC 123 ALB 3,2 CREAT: 1,20 CA 8,5 FA 212 BI: 0,77 BD: 1,13 BT 1,90 GOT : 39 GPT : 86 GGT : 399 LDH : 357 MDRD 57,82 LACTATO : 0,8 PCR 48,5 UREMIA 151 BUN 71 NA 150 K 3.90 CL 112 PH 7.50 PO2 62.2 PCO2 32.3 HCO3 25.5 BE 2.9 PAFI 296
CULTIVO INTRAOPERATORIO 12/04/2024: ESCHERICHIA COLI
UC 12/04/2024: NEG
HC 12/04/2024: NEG
TAC ABDOMEN Y PELVIS 11/04/2024
DILATACIÓN DE VÍA BILIAR INTRA Y EXTRAHEPÁTICA CON IMAGEN SUGERENTE DE COLEDOCOLITIASIS
DIVERTICULOSIS NO COMPLICADA
ATELECTASIAS SUBEGMENTARIAS BIBASALES
EKG 11/04/2024 RS/100/0.08/0.16/0.08/-45°/0.32 VM TS HBSAHH, BIRDHH

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

CRISMAR KARINA IBAÑEZ ROMERO
MEDICO TRATANTE
26788003-4

JEFE SERVICIO